

TEMA 2.9 • GINECOLOGÍA

Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

PERFIL EUNACOM 2.01.1.074

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

1. Vacuna VPH

Prevención primaria (evita la enfermedad).

- **Serotipos cubiertos:** 6, 11 (condiloma acuminado) + **16, 18** (cáncer cervicouterino) → vacuna **tetravalente**
- **Población Chile:** Niñas en 4° y 5° básico (2 dosis)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La vacuna VPH disminuye la incidencia, pero el **PAP-Nicolau tiene mayor impacto poblacional** por ser detección en estadio temprano.

2. PAP-Nicolau (Papanicolaou)

Prevención secundaria (detecta la enfermedad en estadios iniciales).

¿Cuándo y cada cuánto?

TABLA 2.9.1: SISTEMA VS INICIO

SISTEMA	INICIO	FRECUENCIA
AUGE/Sistema Público	25 años	Cada 3 años (hasta 64 años)
Sociedades científicas	Inicio de vida sexual	Anual (espaciar a c/3 años solo si 3 PAP negativos seguidos + pareja estable)

Dos Indicaciones de Colposcopia + Biopsia

- **PAP atípico** (cualquier tipo)
- **Lesión cervical visible** en especuloscopia (aunque el PAP sea normal)

3. Manejo según Resultado del PAP

PAP Normal

→ Control en 1 año (o 3 años si cumple criterios de espaciamiento)

PAP Inflamatorio Inespecífico

→ Igual que normal: **PAP en 1 año** (no es patológico)

PAP Atípico Escamoso de Alto Grado (ASC-H)

→ **Colposcopia + biopsia siempre**

TABLA 2.9.2: RESULTADO COLPOSCOPÍA VS CONDUCTA

RESULTADO COLPOSCOPÍA	CONDUCTA
Displacia bajo grado + colposcopia normal	PAP en 1 año
Colposcopia normal, pero PAP de alto grado (disociación colpo-citológica)	Cono biopsico (cono frío)
Colposcopia insatisfactoria (no se ve zona de transición)	Curetaje endocervical

PAP Atípico Escamoso de Significado Incierto (ASC-US)

- Tres opciones (preferir la primera):
- **PAP en 6 meses** (si sigue igual → colposcopia)
- Tipificación VPH: si alto grado → colposcopia; si bajo grado → PAP en 6 meses
- Directo a colposcopia + biopsia (igual que ASC-H)

PAP Atípico Glandular (AGC / AGC-H / AGC-US)

→ **Colposcopia + biopsia + curetaje endocervical**

TABLA 2.9.3: RESULTADO COLPOSCOPÍA VS CONDUCTA

RESULTADO COLPOSCOPÍA	CONDUCTA
Hallazgo positivo	Tratar según NIC/cáncer encontrado
Colposcopia + curetaje normales	Biopsia de endometrio (sospechar origen endometrial)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Dos indicaciones de curetaje endocervical: 1. PAP escamoso (ASC-H) + colposcopia **insatisfactoria** 2. **PAP glandular atípico** (AGC/AGC-H/AGC-US) → siempre

- **Dos indicaciones de biopsia de endometrio:**
- PAP glandular atípico con colposcopia y curetaje negativos
- Células endometriales en PAP de **mujer postmenopáusica**
-

4. Otros Resultados del PAP

TABLA 2.9.4: RESULTADO VS CONDUCTA

RESULTADO	CONDUCTA
Inflamatorio inespecífico	PAP en 1 año (normal)
Inflamatorio específico (ej. <i>Trichomonas</i>)	Tratar causa específica + manejo ETS
Inflamatorio por <i>Cándida</i>	Tratar solo si sintomática (asintomática: observar)
Actinomyces (con DIU)	Observar (no retirar DIU salvo clínica de PIP)
Muestra insatisfactoria	Repetir PAP de inmediato (mal tomado)
Atrofia endometrial	Estrógenos locales → repetir PAP en 4-6 meses
Células endometriales en postmenopáusica	ETV + biopsia endometrio (descartar cáncer)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir: - **Muestra PAP insatisfactoria** (mal tomado) → repetir PAP de inmediato - **Colposcopia insatisfactoria** (no se ve zona de transición) → curetaje endocervical Son conductas completamente distintas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 1. Vacuna VPH
- 2. PAP-Nicolau (Papanicolaou)
- ¿Cuándo y cada cuánto?
- Dos Indicaciones de Colposcopia + Biopsia
- 3. Manejo según Resultado del PAP
- PAP Normal
- PAP Inflamatorio Inespecífico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO)**PREGUNTA 1**

Respecto a Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Prevención del Cáncer de Cuello Uterino requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Prevención del Cáncer de Cuello Uterino?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

:::tip La vacuna VPH disminuye la incidencia, pero el PAP-Nicolau tiene mayor impacto poblacional por ser detección en estadio temprano. :::
 ::: 1. PAP atípico (cualquier tipo) 2. Lesión cervical visible en especuloscopia (aunque el PAP sea normal) Tres opciones (preferir la primera): 1. PAP en 6 meses (si sigue igual → colposcopia) 2. Tipificación VPH: si alto grado → colposcopia; si bajo grado → PAP en 6 meses 3. Directo a colposcopia + biopsia (igual que ASC-H)